

22 - 9- Les sulfamides - Pr. TASSI

Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui les sulfamides, qui constituent une famille d'antibiotiques très utilisée. Les sulfamides sont utilisés en association avec d'autres anti-infectieux, essentiellement la triméthoprine. Ils sont associés aussi à la pivmécétammine et à l'érythromycine.

Le but de cette association, c'est d'élargir le spectre et d'avoir un effet bactéricide. Nous allons étudier l'association sulfaméthoxazole-triméthoprine, qu'on appelle cotrimoxazole. La sulfaméthoxazole agit par inhibition de la synthèse microbienne de l'acide folique.

Il peut interférer aussi avec la synthèse de l'acide folique humain, ce qui donne les effets secondaires hématologiques, dont l'anémie. La triméthoprine, elle agit par inhibition de la dihydrofolate microbienne. Son spectre d'action, il est étendu vers les entérocoques, la listeria, le staphylocoque aureus, où il est bactériostatique, le pneumocystis carinii, qui est une mycose, et l'isosporidie, qui est un parasite.

Vous voyez ici que l'antibiotique, qui est le cotrimoxazole, a un effet antimycosique et antiparasitaire aussi. Sur ce schéma, nous voyons les deux sites d'action de la sulfaméthoxazole et de la triméthoprine au niveau bactérien. Le cotrimoxazole a une meilleure biodisponibilité, qui atteint 90%, ce qui fait que la posologie, elle est la même, que ce soit intraveineuse ou orale.

Et le cotrimoxazole est indiqué dans le traitement des gastroenterites à germes invasives, comme les salmonelles et les shéigelles, dans le traitement de la listeriose de rominin G, les infections urinaires, vu qu'il a une bonne diffusion au niveau de l'appareil urinaire, aussi bien les voies que le parenchyme rénal et prostatique. Il est indiqué dans le traitement du chancre mou, de la nocardiose, et dans le traitement des infections pneumocystis carinii et isosporidie. Il sert aussi à la prévention primitive et secondaire de la pneumocystose et de la toxoplasmose chez l'immunodéprimé.

Comme on fait indésirable, on a des accidents d'hypersensibilité très importants, qui peuvent aboutir même au syndrome de l'AIEP, qui est une hypersensibilité très grave. Il y a des accidents toxiques dans l'hématologique, vu qu'il interfère avec l'acide folique bactérien et il interfère aussi avec l'acide folique humain, ce qui fait qu'on a la possibilité d'avoir une anémie, d'avoir une leucopénie et d'avoir une thrombopénie comme complication. Des accidents rénaux sont possibles.

Le cotrimoxazole est contre-indiqué chez la femme enceinte ou allaitante d'un nouveau-né, chez le nouveau-né en cas d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatique sévère, d'allergie et en cas de déficit en GCSPD.